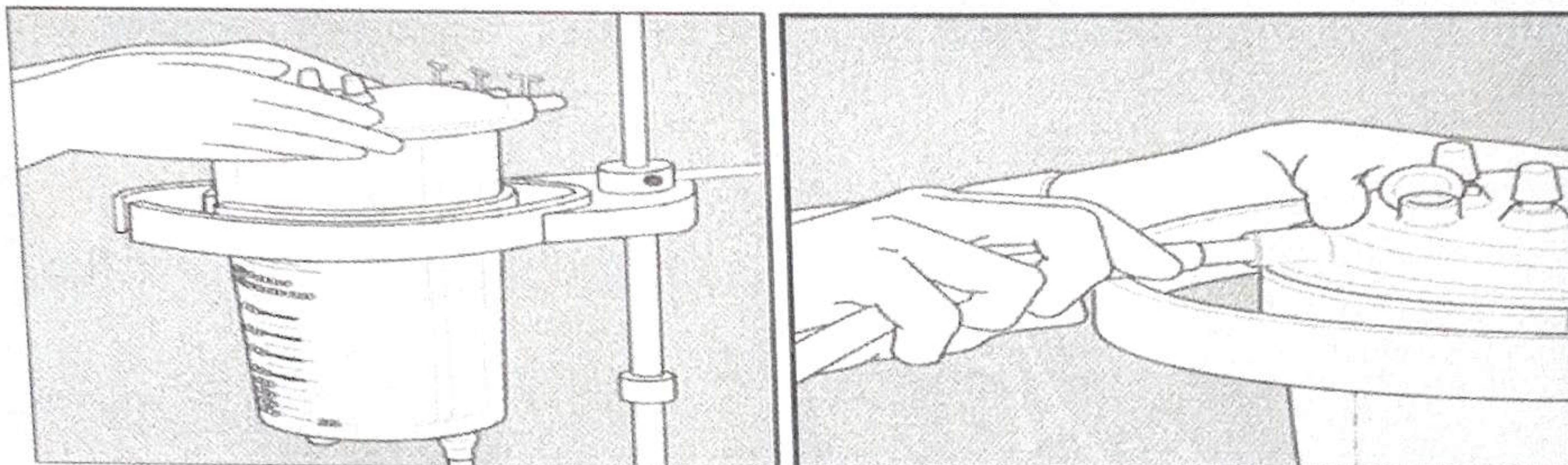
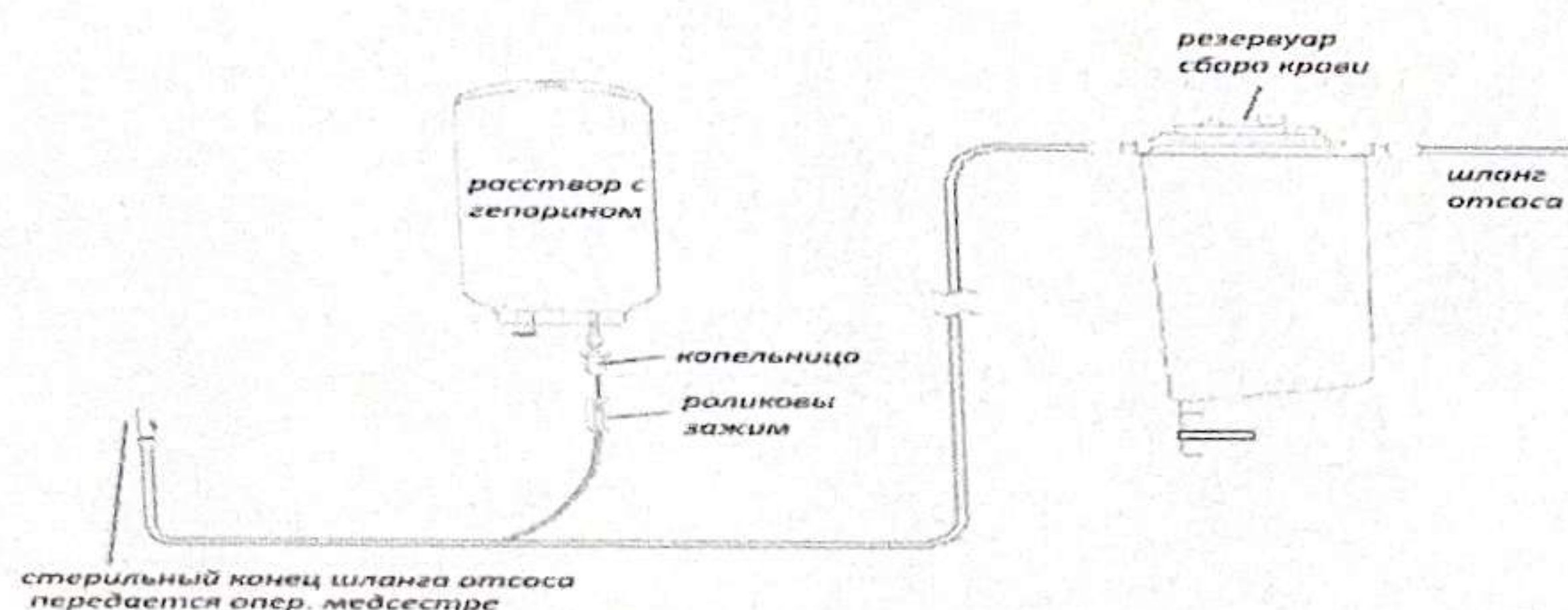


Cell Saver 5+.

- 1) Распаковываем резервуар (колбу) для первичного сбора крови. Размещаем её на стойке-весах таким образом, чтобы жёлтый порт колбы смотрел в разрыв кольца весов.
- 2) К её жёлтому порту подключаем шланг отсоса (является многоразовым).

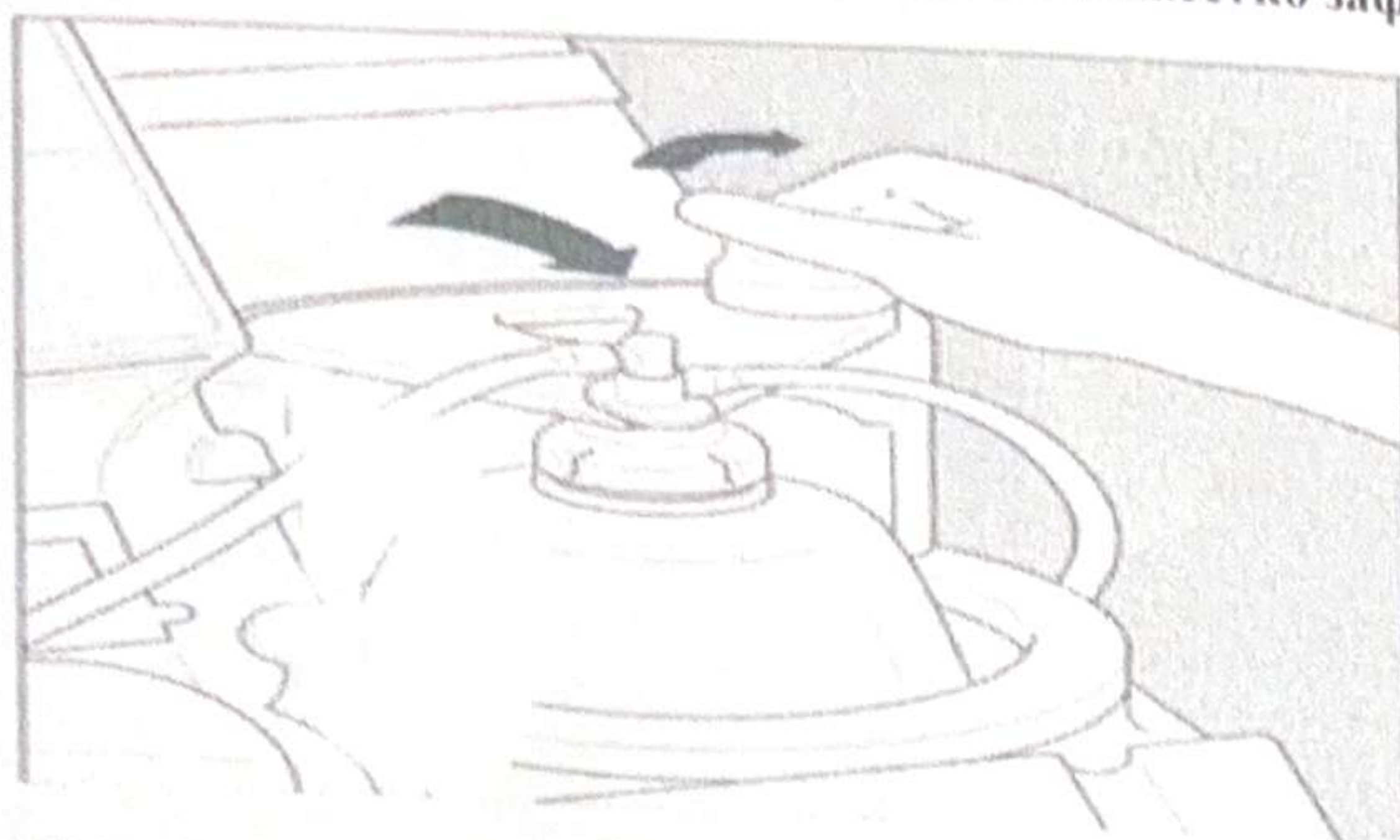


- 3) Вешаем на стойки аппарата 2 флакона с физиологическим раствором хлорида натрия ёмкостью 400 мл для отмывания собранной крови, либо раствор BioWash.
- 4) На стойку аппарата помещаем 400 мл физиологического раствора хлорида натрия в который вводим 2 (два) мл. = 10 000 ЕД гепарина, маркируем флакон надписью "ГЕПАРИН".
- 5) Вскрываем внешнюю упаковку дренажа - линия А&А - аспирации и антикоагуляции и, не касаясь внутренней упаковки, протягиваем комплект операционной сестре, чтобы она могла взять его корнцангом.



- 6) В области стерильной зоны остаётся участок дренажа для сбора излившейся крови пациента. Конец дренажной магистрали с коннектором для антикоагулянта и подсоединения к колбе аппарата операционная сестра отдаёт нам.
- 7) Подсоединяем разъём дренажа к одному из синих портов колбы для сбора крови.
- 8) Подсоединяем конец дренажа с пластиковой иглой к флакону с физиологическим раствором натрия хлорида и ГЕПАРИНОМ.
- 9) Открываем зажим, чтобы физиологический раствор с гепарином мог пройти в колбу и намочить фильтр. Включаем отсос.
- 10) При появлении раствора с гепарином на дне колбы, можно начинать сбор крови из операционной раны.
- 11) Во время сбора крови, открываем упаковку с расходным комплектом. Открываем крышки центрифуги и коллектора с насосом.
- 12) Вешаем магистрали на стойку аппарата. Колокол центрифуги устанавливаем в гнездо, где имеются 6 механических держателей, до щелчка.

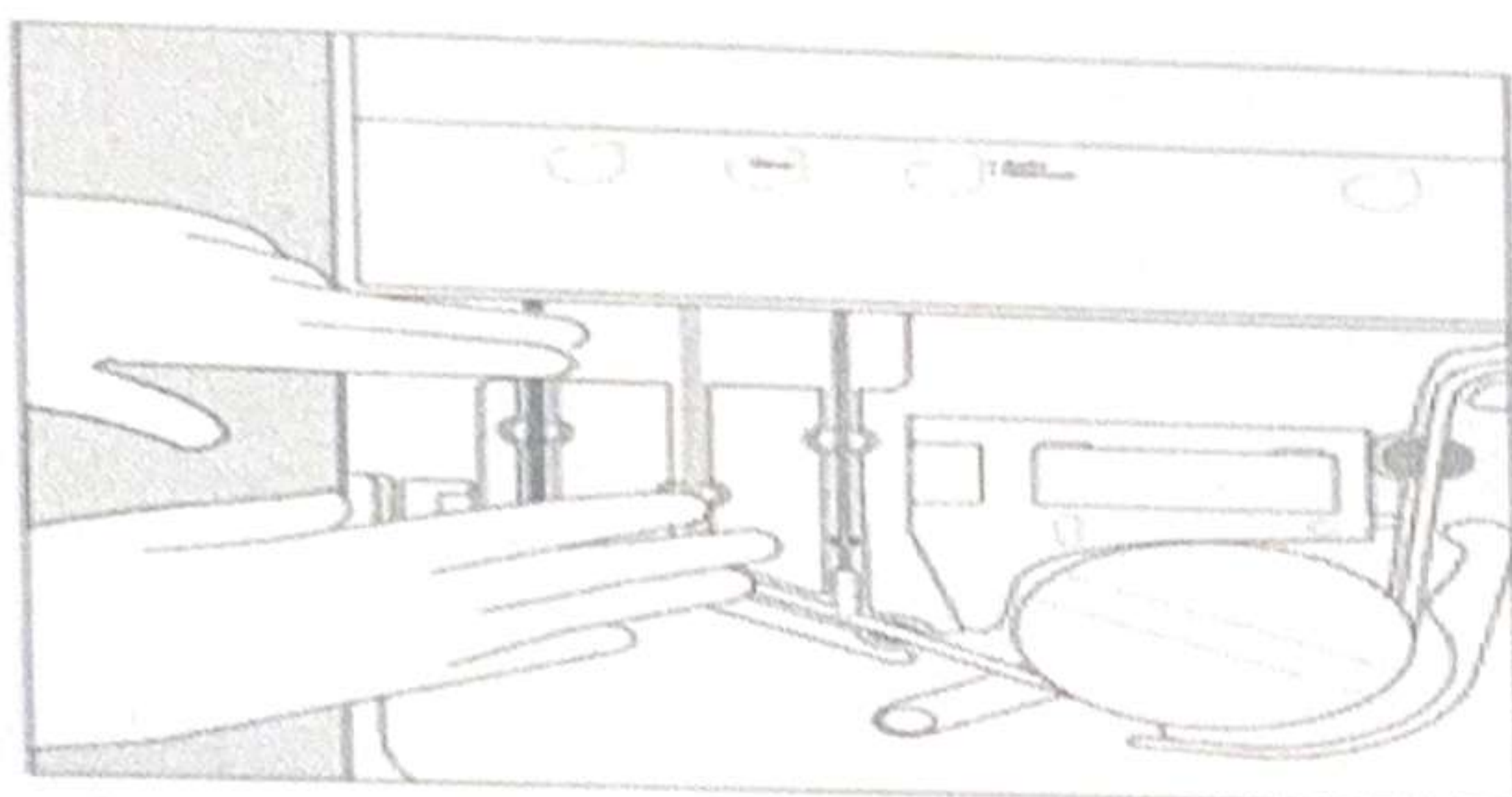
13) Закрываем держатель, удерживающий верхнюю, неподвижную часть колокола, и блокируем его, поворачивая фиксатор синего цвета вправо. В результате установки нижняя часть колокола должна свободно и легко вращаться, а верхняя быть жёстко зафиксирована.



14) Вешаем мешок для сбора отходов на держатели-весы, расположенные по передней поверхности аппарата. Пластиковую магистраль, выходящую из колокола к этому мешку, укладываем в датчик выходной линии (сенсор отходов).

15) Пропускаем магистраль, приводящую к колоколу, в паз и устанавливаем в датчик воздуха. Далее загружаем её в роликовый насос.

16) Устанавливаем коллектор - магистрали красного, жёлтого и синего цвета в пазы с клапанами. Закрываем фиксатор магистрали в роликовом насосе, поворачивая рычажок направо. Закрываем прижимную планку коллектора, блокируя её поворотом фиксатора снизу - вверх. Закрываем крышки аппарата.



17) Подсоединяем две магистрали жёлтого цвета к флаконам с физиологическим раствором натрия хлорида. Магистраль красного цвета к колбе для сбора дренажной крови (нижний, красный порт). Вешаем контейнер для сбора эритроцитов на стойку, перекрываем у него порты для подключения систем для трансфузии.

Заглушки магистралей не выбрасываем.

18) Включаем аппарат кнопкой, расположенной на его правой стороне. Проходит процесс самотестирования, после чего аппарат предлагает установить расходный комплект и нажать кнопку START. Нажимаем клавишу START, аппарат переходит в режим ожидания - при заполнении резервуара для сбора дренажной крови на 400 (по умолчанию) мл, процесс перекачки крови в колокол, отмывки и концентрации эритроцитов в мешке для реинфузии запускается автоматически.

19) При необходимости произвести манипуляции вручную, используем кнопки START (ПУСК), FILL (ЗАПОЛНЕНИЕ колокола) и WASH (ОТМЫВАНИЕ).

20) После завершения работы разбираем расходный комплект в обратной последовательности, используя клапаны и заглушки.

21) Остатки реинфузированной эритроцитарной взвеси пациента, в количестве не менее 5 мл. должны храниться в медицинском холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия в течение 48 часов после трансфузии.